随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

VS 胆囊结石、泌尿结石 二、可能可能最可能：痛吐胀停

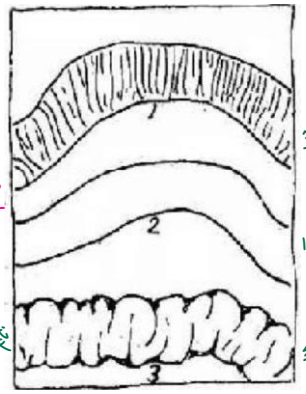
腹痛	阵发性绞痛→机械性 肠管不通畅，平滑肌加强蠕动导致绞痛→肠子累了休息一下→加强扭动 持续性胀痛或不适→麻痹性
相反：呕吐	**呕吐早而频繁、可合并代碱→高位（空肠）** 类似幽门梗阻 **呕吐较晚、含粪样物→回肠** 位置低 **呕吐不明显→大肠** 位置更低，有回盲瓣挡着　营养物质吸收的主要部位：小肠上部
相反：腹胀	腹胀不明显、可见胃型、X 线鱼骨刺状/鱼肋征→高位（空肠）有丰富的粘膜皱壁 **腹胀明显**、可见胃肠型、**X 线阶梯状液气平→低位（回肠、大肠）** 腹胀均匀对称→麻痹性 肠梗阻的腹胀一般都是不均匀不对称的
排便排气	**停止→完全性** **尚有→不完全性** ①不能因为有排便排气就排除肠梗阻，因为有可能是不完全性的肠梗阻 ②即使是完全性的肠梗阻，也有可能会排气排便，因为梗阻点以下的部分可能会积累一定的气体、粪便
肠鸣音 （正常 4-5 次/分）	**肠鸣音增强→机械性（亢进呈金属音调）、痉挛性（如急性肠炎、铅中毒）** **肠鸣音减弱→麻痹性（如腹腔内出血、腹膜炎、腹水、低血钾、阿托品、阿片药、中毒性巨结肠）**中毒性巨结肠本质就是麻痹性肠梗阻，是严重UC在活动期最常见的并发症

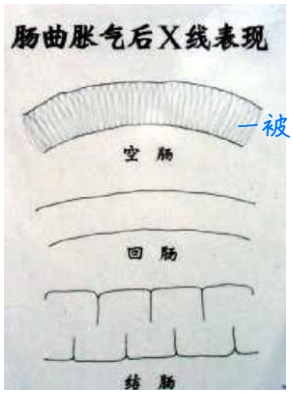
从外面抑制肠子

机械性肠梗阻的晚期也有可能会出现肠鸣音减弱

绞窄性肠梗阻的肠鸣音可增强可减弱，与病程是息息相关的，早期可增强

e.g 本身机械性肠梗阻肠鸣音是增强的，当出现血运障碍就归到绞窄性肠梗阻这一类，若肠管还未缺血坏死，肠鸣音依旧亢进，但随着病情进展，血运障碍的肠道一定会缺血坏死，肠鸣音就减弱消失











阶梯状液气平



